

2022, 22(3):343-346.

- [16] 陈岚榕, 王林林, 陈松, 等. 艾灸曲池、合谷穴结合康复训练对脑梗死恢复期患者上肢功能障碍恢复疗效的回顾性分析[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(12):5652-5655.
- [17] 王浩然. “四关”穴在针灸疑难病证中的功效辨析[J]. 中国中医基础医学杂志, 2019, 25(6):799-801.
- [18] 李晓陵, 刘阳, 王丰, 等. 基于 fMRI 的针刺“四关”穴治疗机制研究进展[J]. 山东医药, 2020, 60(20):88-90.

(修回日期:2024-12-01)

补脾益肺汤治疗变应性鼻炎的临床疗效分析

王 佩, 郑 鑫

(浙江省淳安县第一人民医院耳鼻喉科·浙江 杭州 311700)

变应性鼻炎(AR)是一种由 IgE 介导的慢性鼻部炎症性疾病,全球患病率为 10%~20%^[1];在我国不同地域间的流行病学数据差异相对较大,约为 9.6%~23.9%^[2]。AR 的发病多与遗传、环境、免疫相关,吸烟、呼吸道反复感染、抗生素的过度使用有相关性,患病后多表现鼻痒、眼痒、阵发性喷嚏和流清涕等症状,且反复发作,缠绵难愈^[3]。临床对于 AR 的治疗主要以控制症状,改善生活质量为目标,目前西医主要采用规避变应原及鼻用糖皮质激素、抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等药物治疗,起效较快,短期疗效较佳^[4];但临床实践发现,单独使用西药治疗作用靶点单一,在改善 AR 患者鼻痒、喷嚏、流涕等鼻部症状方面并无明显长期获益,远期疗效并不令人满意,停药后易复发,难以实现多途径、多靶点的整体辨治效果^[5]。而不同于西医的对抗性治疗,中医药在疾病治疗中作用更为广泛,其所含有的中药复方成分更能充分发挥多途径、多靶点、整体协调的独特优势;故临床多将目光转向于中西医结合治疗 AR^[6-7]。在传统中医学中,AR 归属为“鼻鼽”范畴,多由脏腑虚损、正气亏虚所致,其中脾胃虚弱,肺气不足,卫表不固为发病之关键,脾肺气虚为常见证型,治宜健脾宣肺,补气固表。因此,笔者采用自拟补脾益肺汤辅助治疗 AR,并与单纯西药治疗进行对照观察,现总结如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 按随机原则将淳安县第一人民医院耳鼻喉科 2021 年 3 月—2023 年 6 月诊治的 94 例 AR 患者分为 2 组。对照组 47 例,男 26 例,女 21 例;平均年龄 (41.57 ± 4.71) 岁;平均病程 (4.12 ± 1.25) 年;病情严重程度^[8]:中度 32 例,重度 15 例。观察组 47 例,男 27 例,女 20 例;平均年龄 (42.13 ± 4.65) 岁;平均病程 (4.20 ± 1.21) 年;病情严重程度:中度 30 例,重度 17 例。2 组患者一般资料均衡可比($P>0.05$)。

通讯作者:郑鑫, E-mail:1875766094@qq.com

1.2 诊断标准 1)西医诊断参照《变应性鼻炎诊断和治疗指南》^[8]标准;2)中医参照《中医耳鼻喉科常见病诊疗指南》^[9]中“鼻鼽”诊断标准,辨证分型为肺脾气虚证。

1.3 纳入标准 1)符合上述中西医诊断标准;2)年龄 18~65 岁;3)近 4 周无免疫抑制剂、抗过敏药用史;4)患者、家属知情同意,自愿参与研究。

1.4 排除标准 1)合并呼吸道感染者;2)合并急慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉及哮喘者;3)合并内分泌、免疫系统疾病者;4)合并心、脑、肝、肾、胃肠功能障碍者;5)精神疾病患者;6)对本研究所用药物过敏者;7)妊娠期、哺乳期及备孕妇女;8)正在参与其他临床研究者;9)依从性较差者。

2 方法

2.1 治疗方法 对照组:先行鼻腔冲洗,即在单侧鼻孔外侧放置鼻腔冲洗器的橄榄头,患者口腔微张,屏吸,均匀按压冲洗器球囊,至温盐水从对面鼻腔/口腔流出,再同法冲洗对侧鼻腔。之后用糠酸莫米松鼻喷雾剂(Schering-Plough Labo N.V, 国药准字 H20140100, 50 μ g $\times$ 60 揿)喷鼻,两侧鼻孔各 2 喷,1 次/日;并口服孟鲁司特钠片(杭州默沙东制药有限公司),每天 1 片(10 mg/片),睡前服。观察组:在上述治疗基础上加自拟补脾益肺汤(黄芪 30 g、党参 15 g、山药 20 g、白术 15 g、当归 10 g、辛夷 10 g、苍耳子 10 g、白芷 10 g、桔梗 10 g、升麻 6 g、柴胡 10 g、陈皮 10 g、炙甘草 5 g)治疗,腹胀纳差、鼻塞、涕重者加砂仁 3 g、蔓荆子 6 g、干姜 6 g;鼻痒难耐者加蝉蜕、地龙各 6 g;喷嚏频频、畏寒怕冷者加五味子 6 g、防风 9 g;汗多、清涕不止者加浮小麦 15 g、苍术 10 g;每日 1 剂,水煎取药液 300 mL,分早晚各 1 次(150 mL/次)餐后 30 min 温服。2 组患者均连续给药 4 周。

2.2 疗效标准 参照“中医耳鼻喉科病证诊断疗效标准”^[10]中“鼻鼽”的疗效标准。

2.3 观察指标 1)鼻部症状、伴随症状评分(TNSS、TNNSS):治疗前后,参照《变应性鼻炎诊断和治疗指南》^[11]评估。(1)TNSS 评分:对鼻部症状(鼻塞、鼻痒、喷嚏、流清涕)按无、轻微、加重、非常重分别计 0~4 分,总计 16 分;(2)TNNSS 评分:将鼻部伴随症状(鼻涕倒流、流泪、鼻或眼部瘙痒、鼻或口腔上颌疼痛、头痛)按无、有分别计 0、1 分,总分值 5 分。2)中医证候积分:参照《中药新药临床研究指导原则》^[12]积分法评分。3)血清免疫球蛋白 E(IgE):治疗前后,清晨抽取患者 5 mL 外周静脉血,采用 ELISA 检测免疫球蛋白 E(IgE)水平。4)生活质量:治疗前后,采用鼻结膜炎生命质量调查问卷(RQLQ)^[13]评价,共 28 项,每项计为 0~6 分,总分 168 分,分值越高生活质量越低。

2.4 统计学方法 数据使用 SPSS22.0 软件处理。计数资料比较用 χ^2 检验;计量资料比较用 t 检验。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 2 组患者疗效比较 见表 1。

3.2 2 组患者治疗前后鼻部症状及伴随症状评分比较 见表 2。

表 1 2 组患者疗效比较[例(%)]

组别	例数	治愈	好转	未愈	总有效
对照组	47	11(23.4)	24(51.1)	12(25.5)	35(74.5)
观察组	47	15(31.9)	28(59.6)	4(8.5)	43(91.5)*

注:与对照组比较,* $P < 0.05$ 表 2 2 组患者治疗前后 TNSS、TNNSS 评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	时间	TNSS	TNNSS
对照组	治疗前	12.44 ± 1.25	4.13 ± 0.67
(47 例)	治疗后	8.23 ± 1.09 [#]	3.30 ± 0.66 [#]
观察组	治疗前	12.47 ± 1.27	4.12 ± 0.68
(47 例)	治疗后	5.88 ± 0.86 [#]	2.07 ± 0.35 [#]

注:与治疗前比较,[#] $P < 0.05$;与对照组比较,* $P < 0.05$

3.3 2 组患者治疗前后脾胃气虚证候积分比较 见表 3。

表 3 2 组患者治疗前后中医证候积分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后
对照组	47	21.58 ± 2.35	12.32 ± 2.03 [#]
观察组	47	21.60 ± 2.37	8.53 ± 1.86 [#]

注:与治疗前比较,[#] $P < 0.05$;与对照组比较,* $P < 0.05$

3.4 2 组患者治疗前后血清 IgE 比较 见表 4。

表 4 2 组患者治疗前后血清 IgE 水平比较($\bar{x} \pm s$, IU/mL)

组别	例数	治疗前	治疗后
对照组	47	182.57 ± 20.89	125.73 ± 13.82 [#]
观察组	47	182.41 ± 21.53	107.59 ± 10.28 [#]

注:与治疗前比较,[#] $P < 0.05$;与对照组比较,* $P < 0.05$

3.5 2 组患者治疗前后生活质量比较 见表 5。

表 5 2 组患者治疗前后 RQLQ 评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后
对照组	47	122.62 ± 11.27	57.48 ± 8.32 [#]
观察组	47	121.97 ± 12.48	39.82 ± 5.36 [#]

注:与治疗前比较,[#] $P < 0.05$;与对照组比较,* $P < 0.05$

4 讨论

AR 属 IgE 介导的 I 型变态反应,其发病率呈逐年递增趋势。目前,西医主要采用糠酸莫米松鼻喷雾剂和孟鲁司特钠片进行治疗^[14]。糠酸莫米松鼻喷雾剂是治疗 AR 的二代鼻腔激素药物,具有亲脂性、受体结合力、抗炎活性强等特点,并有抗过敏,降低血管通透性,抑制炎症介质释放作用,故能有效缓解鼻、眼部症状,阻止病情进展,现已在临床广泛应用^[15]。孟鲁司特钠片为新型白三烯受体拮抗剂,可通过阻断白三烯通路,抑制肽素生长因子的促成熟作用,减少血中嗜酸性粒细胞,修复 AR 患者 T 细胞功能而减轻炎症反应,改善临床症状^[16]。但均存在以症状缓解为主而难以根治的局限性。因此,临床实践中应积极探索更有效的治疗手段。中医治疗 AR 以整体观和辨证论治为基础遣方用药,临床取得显著疗效^[17-18]。

AR 属中医学“鼻鼽”范畴,临床多以虚证居多,其中以脾胃气虚证最为常见^[19]。脾为肺之母,若脾虚而失于运化,则影响气血生化,致肺气虚弱,腠理疏松,卫表不固,易受风寒之邪侵袭,邪聚鼻窍,致患者鼽嚏经久不愈。正如《杂病源流犀烛》记载:“鼻鼽,鼻流清涕不止者,多由肺经受寒而

成。”故治宜“培土生金”,标本兼治,补脾益肺固表以治本,通窍祛邪止涕以治标。所拟补脾益肺汤方中,黄芪为君药,入肺脾经,为健脾补肺,益气固表升阳之要药。白术、党参健脾益气、燥湿利水,升麻、柴胡疏通气机、透邪达表、升举阳气,山药滋养脾胃、补益肺肾,五味合用助黄芪补脾肺,促进气血生化,卫外固表;桔梗开宣肺气,辛夷外除风寒、内升清气、利鼻开窍,苍耳子祛风湿、通鼻窍,白芷祛风解表除湿、消肿通窍,以上共为臣药。佐以当归与芪参调和营卫,陈皮理气降浊,补而不腻。炙甘草为使,温而补中、调和诸药。纵观全方,温、补、升、降具备,使气虚得补、气陷得升,共奏补益脾肺、固腠益卫、开通鼻窍之效。现代药理研究证实,上方中黄芪、党参等补气健脾中药具有增强免疫功能作用,并可减轻鼻黏膜损伤,有明显的抗过敏、抗炎作用^[20-21];白术可保护 AR 小鼠鼻黏膜组织,有效缓解 AR 症状^[22];辛夷挥发油可有效阻止组胺大量释放对 Th1/Th2 平衡的破坏,进而治疗 AR^[23];升麻含有的三萜皂苷类化合物可增强对神经内分泌的调节,提高机体免疫力^[24];甘草甜素能够作用于肥大细胞脱颗粒,抑制促炎因子释放,进而发挥抗炎特性^[25]。

本文结果显示,治疗后观察组与对照组相比,总有效率明显提高($P < 0.05$);TNSS、TNNSS 评分、中医证候积分、RQLQ 评分明显降低($P < 0.05$);IgE 水平显著降低($P < 0.05$)。可见,中药补脾益肺汤与西药联合治疗 AR 疗效显著,可调节免疫功能,缓解症状,改善生活质量,相关的作用机制以及抗复发效果还有待进一步观察研究。

参考文献

- [1] 何璐宏,陈檬,张佳琦. 变应性鼻炎发病流行病学特征及与血清 IFN- γ 及 IL-4 水平的相关性分析[J]. 公共卫生与预防医学,2023,34(1):113-116.
- [2] 祝戎飞,刘争. 变应性鼻炎的分级预防[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(4):379-384.
- [3] 魏欣. 变应性鼻炎发病机制[J]. 海南医学,2011,22(10):8-12.
- [4] 肖英,马新春,石磊,等. 变态反应性鼻炎发病机理及治疗进展[J]. 2012,42(2):89-92.
- [5] 吴飞虎,查必祥,张婷婷,等. 扶阳固本针灸法治疗常年性变应性鼻炎远期疗效观察及对患者血清总免疫球蛋白 E、白细胞介素-4 的影响[J]. 针刺研究,2023,48(6):600-605.
- [6] 俞媛,范尧夫. 中医药治疗变应性鼻炎的研究进展[J]. 江西中医药,2012,43(11):78-80.
- [7] 郭姝利,史随随,黄小玲,等. 变应性鼻炎的中西医结合药物治疗进展[J]. 新疆中医药,2018,36(4):112-115.
- [8] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 变应性鼻炎诊断和治疗指南[J]. 中国临床医生,2010,38(6):67-68.
- [9] 中华中医药学会发布. 中医耳鼻喉科常见病诊疗指南[M]. 北京:中国中医药出版社,2011:20-23.
- [10] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京:南京大学出版社,1994:124.
- [11] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 变应性鼻炎诊断和治疗指南(2015,天津)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016,51

(1):6-24.

[12] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2002.

[13] 何霞,冯彦,王斌全,等. 变应性鼻炎健康相关生存质量测定常用量表简析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,31(1):23-26.

[14] 罗玉,古庆家. 变应性鼻炎的治疗进展[J]. 实用医院临床杂志,2021,18(3):211-213.

[15] 李治美. 糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗变应性鼻炎 40 例疗效评价[J]. 中国药业,2013,22(12):47-48.

[16] 陈玉卿,穆会君,张桢,等. 孟鲁司特钠辅助治疗老年变应性鼻炎的疗效及对 IL-6、IL-8、IL-10 的影响[J]. 中国老年杂志,2016,36(13):3263-3265.

[17] 唐代屹,郭赛珊,梁晓春. 中药复发防治变应性鼻炎机制研究进展[J]. 山东中医杂志,2000,19(1):55-56.

[18] 刘巧平,刘建华,刘大新. 中医药治疗变应性鼻炎的研究进展[J]. 北京中医药大学学报,2002,25(2):63-65.

[19] 刘慧霞,肖志贤,吴跃,等. 变应性鼻炎(鼻鼽)中医辨证分型的研究进展[J]. 四川中医,2021,39(3):219-223.

[20] 林立佳. 健脾益气方药现代药理学研究[J]. 中国中医基础医学杂志,2002,8(10):78-80.

[21] 王婉莹,姜思亮,柴军红,等. 黄芪和人参配伍的药理作用及临床应用研究进展[J]. 中医药学报,2023,51(8):104-109.

[22] 顾思浩,孔维崧,张彤,等. 白术的化学成分与药理作用及复方临床应用进展[J]. 中华中医药学刊,2020,38(1):69-73.

[23] 王萍,张海燕,刘英孟,等. 辛夷挥发油的化学成分、药理作用及临床应用研究进展[J]. 中国药房,2022,33(3):378-384.

[24] 黄广欣,龚苏晓,许浚,等. 升麻研究进展及其质量标志物的预测分析[J]. 中草药,2020,51(10):2651-2660.

[25] 马汉伟,张明,白银亮,等. 甘草西定的药理学研究进展[J]. 中成药,2023,45(11):3702-3708.

(修回日期:2024-11-30)

八味通窍散内服联合中药熏鼻治疗慢性鼻炎的疗效观察

谢双智,夏美玲,陈叶莲,钟志明,施巧群

(浙江省象山县中医医院医疗健康集团·浙江 宁波 315700)

慢性鼻炎(CR)是指鼻腔黏膜及黏膜下层组织的慢性炎症,临床特征为鼻黏膜充血、水肿、分泌物增多,典型症状为头昏、头闷痛、鼻塞、多涕及嗅觉障碍,病程较长,通常持续数月以上。多因急性鼻炎未能得到规范治疗,或患者自身抵抗力较差,病程迁延引起。缠绵难愈,反复发作,即使在间歇期也不能恢复正常,严重影响患者的生活质量。其发病与感染、免疫功能异常、过敏、内分泌失调、职业环境、空气污染、不良生活习惯等多种因素有关^[1-3]。CR 是一种难治愈性疾病,单用西药治疗虽有一定疗效,但效果并不显著,且复发率较高;而中医治疗 CR 则注重整体辨证施治,能激发、调动机体的自主调理机制,且安全无副作用,具有独到之处^[4]。故

多数学者研究认为采用中西医结合综合疗法效果更好^[5-6]。本研究即在西医常规治疗基础上予自制八味通窍散联合熏鼻治疗慢性鼻炎 35 例,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择本院 2022 年 1 月—2023 年 2 月接诊的 70 例慢性鼻炎患者作为研究对象,采用随机数字表法将 70 例患者随机分为对照组和观察组,每组 35 例。对照组中男 19 例,女 16 例;年龄 20~65 岁,平均(32.27±4.18)岁;病程 1~3 年,平均(1.50±0.50)年。观察组中男 20 例,女 15 例;年龄 20~65 岁,平均(32.26±4.20)岁;病程 1~3.5 年,平均(1.55±0.75)年。2 组患者基线资料比较差异无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 纳入标准 1)符合慢性鼻炎的诊断标准^[7];2)年龄 20~65 岁;3)患者签署知情同意书,自愿参加本研究。

1.3 排除标准 1)急性鼻炎、鼻息肉患者;2)合并其他呼吸系统疾病者;3)由鼻部外伤引起的鼻部症状者;4)患有鼻部肿瘤者;5)感染性鼻炎者;6)合并其它恶性肿瘤者;7)正在接受其他临床试验者;8)近期服用相关药物者;9)重要脏器功能障碍或其他严重系统性疾病者;10)孕期或哺乳期女性;11)对本研究用药过敏者。

2 方法

2.1 治疗方法 2 组均按指南^[7]给予常规西药治疗。在此基础上对照组予中药熏鼻治疗,将艾叶、白芷、防风等药研磨成粉末,取适量药粉加入水中,搅拌均匀,煎煮 10 min,放入鼻炎专用熏鼻器中进行熏蒸,每次熏鼻 10~15 min,控制药温在 37~40℃,每日 2 次,持续治疗 4 周。观察组在上述治疗同时再予八味通窍散内服治疗,方药组成包括辛夷 10 g、苍耳子 6 g、白芷 10 g、蔓荆子 5 g、太子参 10 g、党参 10 g、苍术 5 g、薄荷叶 2 g,将上 8 味药按比例配制成散剂备用。服用方法:每次 5~10 g,每日 2~3 次,餐后服用,持续治疗 4 周。治疗期间要做好日常护理,慎起居避风寒,忌食生冷刺激性食物,避免接触刺激性气体。

2.2 疗效标准 参照“中医耳鼻喉科病证诊断疗效标准”^[8]中“鼻窒”的疗效标准评价疗效。

2.3 观察指标 1)症状缓解时间:记录 2 组患者鼻塞、流涕、头闷痛、嗅觉障碍的缓解时间。2)复发情况:比较 2 组治疗结束后 3 个月、6 个月的复发情况。

2.4 统计学方法 应用 SPSS28.0 软件进行数据分析;计量资料以($\bar{x}\pm s$)表示,组内比较采用配对样本 t 检验,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料比较采用 χ^2 检验; $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 2 组患者疗效比较 见表 1。

表 1 2 组患者疗效比较[例(%)]

组别	例数	治愈	好转	未愈	总有效
对照组	35	17(48.6)	10(28.6)	8(22.9)	27(77.1)
观察组	35	20(57.1)	13(37.1)	2(5.7)	33(94.3) [△]

注:与对照组比较,△ $P<0.05$